

МАНИФЕСТАЦИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ	
Листовка - Приложение 2	
Код Рег. №	20000456
Разрешение №	35637 / 22-11-2018
Одобрение №	

Листовка: информация за пациента

Карбамазепин Актавис 200 mg таблетки
Carbamazepin Actavis 200 mg tablets

карбамазепин (carbamazepine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

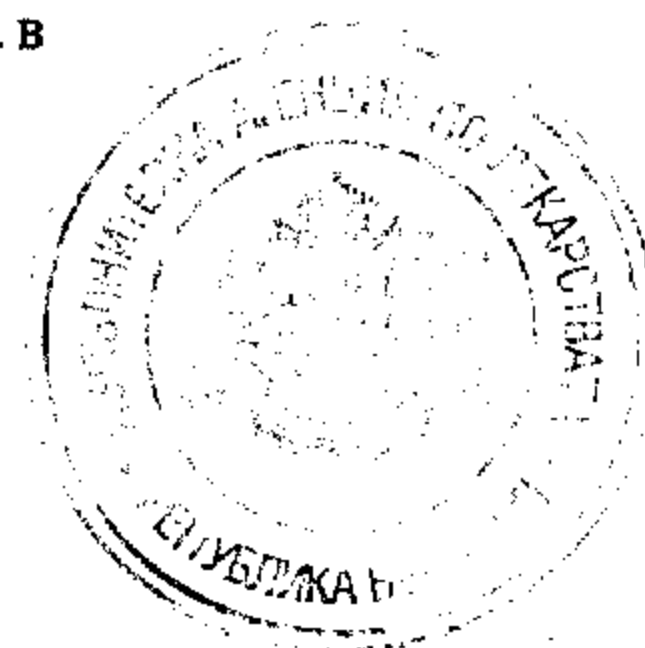
1. Какво представлява Карбамазепин Актавис и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Карбамазепин Актавис
3. Как да приемате Карбамазепин Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Карбамазепин Актавис
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Карбамазепин Актавис и за какво се използва

Карбамазепин притежава противогърчов ефект и потиска болката при невралгия на тригеминалния (троичния) и глософарингеалния (езико-гълтачния) нерв. Механизмът на действието му остава неизяснен. Допълнително оказва седативно (успокоително) и антидепресантно действие. Повлиява някои психични симптоми.

Карбамазепин Актавис се използва при лечението на:

- епилепсия (неврологично заболяване, характеризиращо се с повтарящи се пристъпи, които често се придружават от нарушения на съзнанието). Прилага се и при комплексни или прости частични пристъпи (със или без загуба на съзнание) със или без вторично разпространение, както и при разпространени (генерализирани) тонично-клонични и смесени форми на пристъпи. Карбамазепин Актавис е подходящ, както за самостоятелно лечение, така и при комбинирана терапия с други лекарства. Продуктът не е ефективен при абсанс (малък припадък) и миоклонични гърчове.
- остра мания и поддържащо лечение при биполарни афективни разстройства за предотвратяване и намаляване на повторенията;
- синдром на алкохолна абстиненция (група от симптоми с различна тежест и съчетание помежду си, които се появяват след пълно спиране или намаление приема на алкохол);
- тригеминална невралгия (болка в лицевата област в областта на троичния нерв) с различен произход, вкл. множествена склероза, както и невралгия на езико-гълтачния нерв с неясен произход;
- болезнена диабетна невропатия (усложнение на захарния диабет с промяна в чувствителността на крайниците в резултат на увреждане на нервите);



- безвкусен диабет – повишено отделяне на урина (полиурия) и прекомерно пиене на течности (полидипсия) с неврохормонален произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Карбамазепин Актавис

Не приемайте Карбамазепин Актавис:

- ако сте алергични към карбамазепин, към лекарства с подобна структура (напр. трициклически антидепресанти, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате определен вид нарушения в проводимостта на сърцето (атриовентрикуларен блок);
- при увреждане на костния мозък;
- чернодробна порфирия – заболяване, свързано с нарушения в образуването на порфирина (пигмент, необходим за функционирането на черния дроб и кръвообразуването);
- ако страдате от остра форма на чернодробна недостатъчност;
- ако употребявате моноаминоксидазни инхибитори, т.нар. МАО-инхибитори (вид антидепресанти) или сте ги употребявали през последните 14 дни.

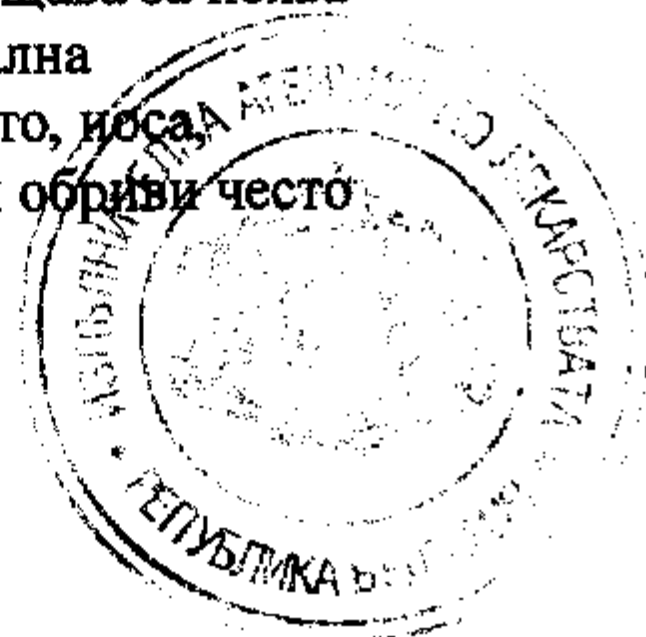
Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Карбамазепин Актавис:

- ако сте бременна или планирате да забременеете;
- ако кърмите;
- ако страдате от вид епилепсия, при която получавате абсанси (малки припадъци) или имате миоклонус. В тези случаи употребата на карбамазепин не е ефективна;
- ако имате смесен тип епилепсия, което включва абсанси (както типични, така и атипични) след приложение на карбамазепин състоянието Ви може да се влоши;
- ако сте в старческа възраст (над 65 години);
- ако имате повишено вътреочно налягане (глаукома) или затруднения със задържането на урината;
- ако страдате от заболяване на кръвта (включително и такова, предизвикано от други лекарства);
- ако някога сте имали необичайна чувствителност (обрив или други признаци на алергия) към окскарбазепин или към някое друго лекарство. Важно е да знаете, че ако сте алергичен/на към карбамазепин, вероятността е приблизително 1 на 4 (25%) да сте алергичен/на и към окскарбазепин (Трилептал). Възможно е да получите алергия и към фенитоин.
- ако имате или сте имали сърдечно, чернодробно или бъбречно заболяване в миналото;
- ако Вашият лекар или фармацевт Ви е казал, че страдате от психично заболяване, наречено психоза, което може да е придружено от обърканост или възбуда;
- ако сте жена, приемаща хормонални контрацептиви (противозачатъчни лекарства). Карбамазепин може да направи Вашия контрацептив неефективен. Поради тази причина, трябва да използвате допълнителен нехормонален контрацептивен метод, докато приемате карбамазепин. Това ще спомогне за предпазване от нежелана бременност. Информирайте Вашия лекар, ако имате нередовно кървене или зацапване. Ако имате въпроси, обърнете се към Вашия лекар или друг медицински специалист.

Ако по време на лечението получите нещо от изброеното по-долу, незабавно информирайте Вашия лекар:

- ако получите сериозни кожни реакции. При употреба на карбамазепин се съобщава за поява на сериозни кожни обриви (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза). Често обривът се съпровожда с образуване на язви в устата, гърлото, носа, половите органи и конюнктивит (червени и подути очи). Тези сериозни кожни обриви често



се предшестват от грипоподобни симптоми, висока температура, главоболие, болки по тялото. Обривът може да прогресира до широко разпространени мехури и лющене (белене) на кожата. Най-висок риск за поява на сериозни кожни реакции съществува в рамките на първите седмици от лечението.

Тези сериозни кожни реакции се срещат по-често при хора от някои азиатски страни. Рискът от такива реакции при китайци или тайландци може да се предвиди при изследване на кръвта на тези пациенти. Преди да започнете да приемате карбамазепин Вашият лекар трябва да Ви уведоми дали е необходимо да си направите кръвен тест.

При поява на обрив или на тези кожни симптоми спрете приема на карбамазепин и се свържете с Вашия лекар незабавно.

Понякога могат да настъпят леки кожни реакции като зачервявания и обриви по кожата, които са преходни и отзвучават след време или при понижаване на дозата на продукта. Трябва да се прави разлика между тези леки и преходни състояния и ранните признаци на сериозните кожни реакции, които налагат незабавно спиране на прилагането на продукта.

- ако броят на епилептичните Ви пристъпи се учести, кажете на Вашия лекар незабавно;
- ако имате симптоми характерни за хепатит, като гадене, тежест под ребрата в дясно, пожълтяване на кожата или очите;
- ако по време на лечението по-често боледувате от инфекции (повишена температура с възпалено гърло, афти), чувствате слабост или започнете лесно да получавате синини или подкожни кръвоизливи;
- малка част от пациентите, лекувани с антиепилептични лекарства, като карбамазепин са имали мисли и идеи за самонараняване или самоубийство. Ако по всяко време имате такива мисли, незабавно се свържете с Вашия лекар.

По време на лечението Вашият лекар ще Ви назначава някои изследвания на кръвта, за да проверява определени кръвни показатели. При определени заболявания е възможно да проследява стойностите на карбамазепин в кръвта.

Други лекарства и Карбамазепин Актавис

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и лекарства без лекарско предписание.

Карбамазепин може да окаже влияние върху други лекарства или действието му може да бъде повлияно от други лекарства. Ето защо е важно да уведомите лекуващия си лекар, ако приемате следните лекарства:

- изониазид и рифампицин (за лечение на туберкулоза);
- сърдечно-съдови (верапамил, дилтиазем, дигоксин, вкл. дихидропиразинови производни, като фелодипин, израдипин);
- противоязвени (циметидин, омепразол);
- антибиотици (еритромицин, кларитромицин, доксициклин);
- противогъбични (итраконазол, кетоконазол, флуконазол);
- за лечение на депресия (бупропион, циталопрам, тразодон, флуоксетин, флувоксамин, тразодон, имипрамин, кломипрамин, амитриптилин, нортриптилин);
- други средства за лечение на епилепсия (вигабатрин, фенобарбитал, фенитоин, мефенитоин, примидон, клоназепам, етосуксимид, примидон, валпроева киселина, ламотригин, окскарбазепин, топирамат, тиагабин);
- антипсихотици (оланзапин, халоперидол, клозапин, тиоридазин, литий, кветиапин, рисперидон);
- анксиолитици (алпразолам);
- инхибитори на карбоанхидразата (като ацетазоламид, използван за лечение на глаукома);



- антивирусни (протеазни инхибитори за лечение на СПИН (ритонавир, индинавир, секвинавир));
- обезболяващи и противовъзпалителни (декстропропоксифен, парацетамол, трамадол, метадон);
- антиалергични (лоратадин);
- противотуморни средства (цисплатин, доксорубицин, иматиниб);
- антиастматични (теофилин, аминофилин);
- лекарства за лечение на кожни заболявания (изотретиноин);
- мефлокин (за лечение на малария);
- кортикостерониди (дексаметазон)
- средства потискащи имунната система (циклоспорин);
- противосъсирващи (варфарин, аценокумарол);
- хормонални противозачатъчни средства;
- хормонозаместителна терапия (гестринон, тиболон, торемифен);
- левотироксин (за лечение на понижена функция на щитовидната жлеза);
- метоклопрамид (средство срещу повръщане);
- диуретици (отводняващи средства), като хидрохлортиазид, фуросемид;
- недеполяризиращи миорелаксанти (средства, отпускащи мускулатурата, като панкуроний);
- лекарства или добавки, които съдържат никотинамид (витамин от група В).

Карбамазепин Актавис с храна, напитки и алкохол

Карбамазепин Актавис, подобно на другите вещества с ефект върху нервната система, може да намали поносимостта към алкохол. Не консумирайте алкохол, докато приемате Карбамазепин Актавис.

По време на лечението с Карбамазепин Актавис не трябва да се консумира грейпфрут или сок от грейпфрут, поради това, че в него се съдържат вещества, които способстват за повишаване нивата на карбамазепин в кръвта. Това може да доведе до усилване на ефекта му и до развитието на нежелани реакции.

Пациентите на лечение с Карбамазепин Актавис трябва да избягват употребата на билкови продукти, съдържащи жълт кантарион (*Hypericum Perforatum*), тъй като може да се понижат нивата на карбамазепин в кръвта и, съответно, терапевтичният му ефект.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

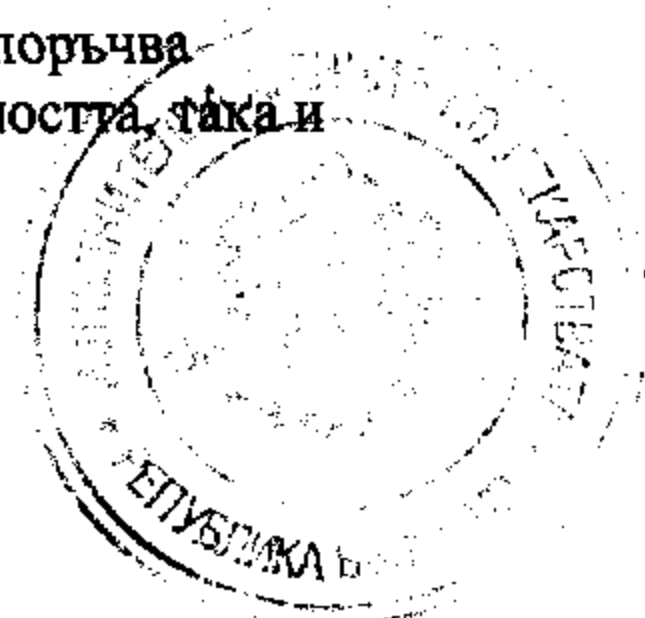
Бременност

Ако забременеете, докато приемате карбамазепин веднага трябва да кажете на Вашия лекар. Важно е епилепсията Ви да е добре контролирана, но както и с други лекарства за лечение на епилепсия, така и при употребата на карбамазепин съществува риск от увреждане на плода. Уверете се, че сте много наясно с рисковете и ползите от приема на Карбамазепин Актавис.

По време на бременност антиепилептичното лечение не трябва да се прекъсва, тъй като обострянето на заболяването вреди както на майката, така и на плода.

По време на бременност може да се развие недостиг на фолиева киселина, който може допълнително да се задълбочи при употребата на карбамазепин и да доведе до повишена честота на вродените дефекти в потомството на майка, лекуваща се с продукта. В такива случаи е необходимо да се приемат допълнителни количества фолиева киселина преди и по време на бременност.

С цел предотвратяване нарушенията в кръвосъсирването при новородените, се препоръчва приложението на витамин K1, както при майката в последните седмици на бременността, така и при новороденото.



Кърмене

Майките, приемащи карбамазепин могат да кърмят бебетата си, но трябва възможно най-бърз да уведомят лекаря, ако смятат, че бебето страда от нежелани лекарствени реакции, като много силна сънливост, алергични кожни реакции или пожълтяване на кожата и очите, потъмняване на урината или обезцветени изпражнения.

Шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за адекватни реакции може да се наруши поради световъртеж и повишена сънливост, дължащи се на карбамазепин. Това се получава най-често в началото на лечението или при прием на високи дози. Необходимо е повишено внимание при шофиране или работа с машини.

3. Как да приемате Карбамазепин Актавис

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Карбамазепин Актавис може да се приема по време или след хранене с достатъчно количество течност, за да се избегне възможното дразнене на стомаха и за по-лесно усвояване на активното вещество през лигавицата на червата.

Епилепсия

Възрастни

Обикновено лечението започва с прием на ½-1 таблетка (100-200 mg) два пъти дневно, като дозата може да се повишава постепенно до достигане на 2 таблетки (400 mg) два или три пъти дневно до постигане на най-добър ефект; при някои пациенти е необходима дозировка от 1 600 mg или 2 000 mg.

Препоръчителната дневна доза на карбамазепин не трябва да надвишава 1 200 mg. Максималната дневна доза не трябва да надвишава 1 600 mg, тъй като по-високи дози повишават честотата на нежеланите лекарствени реакции.

Употреба при деца

Деца под 4 годишна възраст – начална доза 20-60 mg дневно (или 5 mg/kg телесно тегло), след което дозата трябва да се повишава постепенно с по 20 до 60 mg през ден, докато е достатъчна за постигане на желания ефект. Деца под 4 години първоначално трябва да приемат друга лекарствена форма на карбамазепин, тъй като таблетките карбамазепин от 200 mg не могат да доставят доза от 20-60 mg.

При деца над 4 години лечението започва с ½ таблетка (100 mg) дневно, последвано от ежеседмично или на всеки два дни увеличение с по ½ таблетка (100 mg) до постигане на оптималната доза. Въпреки посоченото по-горе, максималната поддържаща дневна доза не трябва да се надвишава.

Поддържаща доза: 10 – 20 mg/kg телесно тегло дневно, както следва:

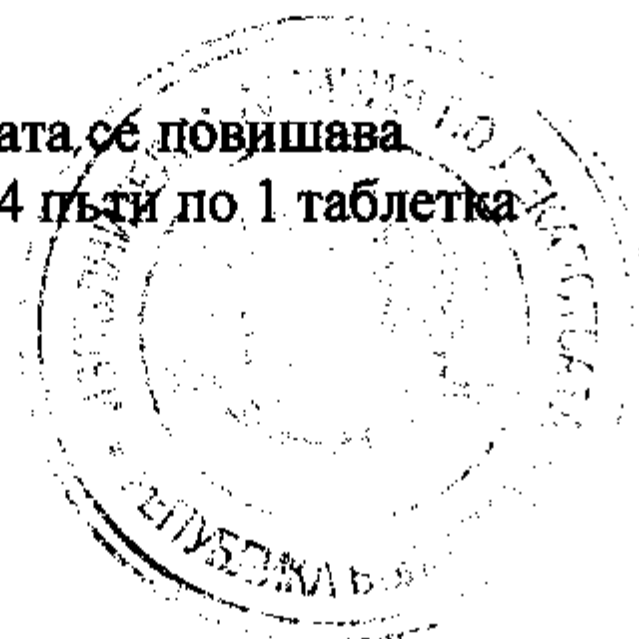
деца от 1 до 5 години: 1-2 таблетки (200-400 mg) дневно

деца от 6 до 10 години: 2-3 таблетки (400-600 mg) дневно

деца от 11 до 15 години: 3-5 таблетки (600-1 000 mg) дневно

Тригеминална невралгия

Началната дневна доза е 1-2 таблетки (200-400 mg) дневно, след което дозата се повишава постепенно до постигане на пълно облекчаване на болката (обикновено 3-4 пъти по 1 таблетка).



дневно). След отзвучаване на болката се уточнява минималната ефективна доза чрез постепенно понижаване на началната доза.

Някои пациенти могат да бъдат лекувани с редуцирана поддържаща дневна доза, т.е. 400 mg (2 таблетки), която трябва да се приема два пъти дневно.

Пациенти в старческа възраст и пациенти, които са чувствителни към лекарствения продукт първоначално трябва да приемат 100 mg ($\frac{1}{2}$ таблетка) 2 пъти дневно.

Синдром на алкохолна абстиненция

Началната доза е 1 таблетка (200 mg) три пъти дневно в първите няколко дни, след което при тежки случаи дозата може да се повиши до 2 таблетки (400 mg) 3 пъти дневно. Уместно е прилагането и на седативни хипнотици (успокоителни, сънотворни). След отзвучаване на острия стадий лечението може да се продължи само с карбамазепин.

Остра мания и профилактика на биполярни афективни разстройства

Началната доза е 200-400 mg (1-2 таблетки). Необходимата доза е между 2-8 таблетки (400 и 1 600 mg) дневно. Най-често се прилагат 2-3 таблетки (400-600 mg), в 2-3 приема.

При лечение на остра мания дозата се увеличава по-бързо, докато при профилактика на биполярно разстройство това става по-бавно, за да се осигури оптимална поносимост.

В редки случаи (когато литият не е достатъчен за предпазване от биполярно афективно разстройство) карбамазепин се прилага едновременно с литий, като се проследяват плазмените нива.

Не се разрешава едновременна употреба с невролептици. Невролептици не трябва да се приемат най-малко осем седмици преди прием на карбамазепин.

Безвкусен диабет – централен тип

Обичайната дозировка за възрастни е 1 таблетка (200 mg) 2-3 пъти дневно. При деца дозировката трябва да се намали пропорционално на възрастта и теглото.

Болестена диабетна невропатия

Обичайна дозировка – 1 таблетка (200 mg) 2-4 пъти дневно.

Пациенти с бъбречна недостатъчност

При пациенти с увредена бъбречна функция се препоръчва прилагане на по-ниска доза.

Пациенти с тежки сърдечно-съдови, чернодробни и бъбречни заболявания и пациенти в старческа възраст трябва да приемат по-ниски дози.

Ако сте приели повече от необходимата доза Карбамазепин Актавис

Ако случайно сте приели голямо количество таблетки, веднага информирайте Вашия лекар, тъй като може да се нуждаете от спешна медицинска помощ.

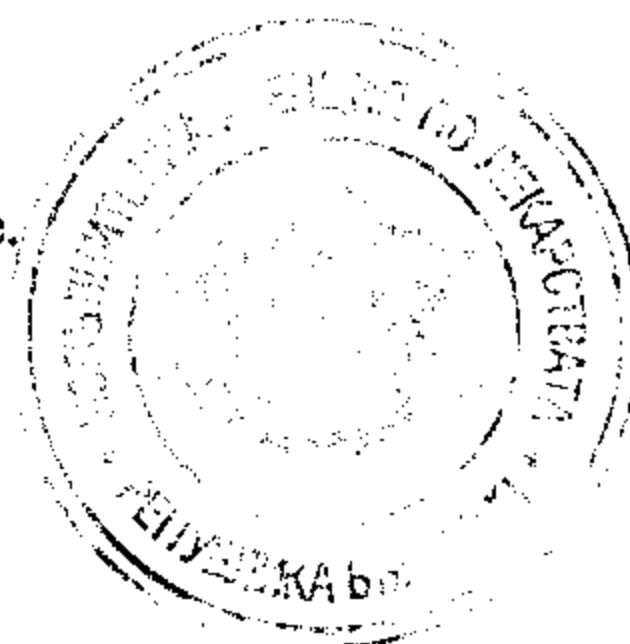
Ако почувствате затруднение в дишането, учестен и нарушен сърдечен ритъм, загубите съзнание или припаднете, имате втрисане, гадене и/или повръщане е възможно предписаната доза да е много висока. Спрете приема на лекарството и веднага уведомете лекуващия си лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Карбамазепин Актавис

Ако се пропусне една доза, тя трябва да се вземе възможно най-скоро. В случай, че е настъпило време за следващата доза е добре да се пропусне забравената и да се продължи по предписаната схема. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Карбамазепин Актавис

Не прекратявайте употребата на лекарствения продукт без лекарско решение.



Внезапното спиране на лечението с карбамазепин може да предизвика гърч. При необходимост от внезапно преустановяване на терапията с продукта при пациенти с епилепсия, преминаването към новият антиепилептичен лекарствен продукт трябва да се извърши при едновременен прием и на друго, подходящо лекарство.

Най-често лечението на епилепсията е продължително. Винаги когато трябва да се прилага карбамазепин, продължителността и прекратяването на лечението се определят от специалист в тази област. Обикновено, за понижаване на дозата или прекратяване на лечението може да се мисли най-рано 2-3 години след последните гърчове. При спиране на лечението е необходимо дозата да се понижава постепенно, в продължение на 1-2 години.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В началото на терапията с Карбамазепин Актавис, ако началните дози са много високи или при пациенти в старческа възраст, могат да възникнат много често или често следните нежелани реакции: от страна на централната нервна система (ЦНС) (световъртеж, главоболие, нарушения в равновесието и координацията на движенията, сънливост, повишена умора, двойно виждане), стомашно-чревни смущения (гадене, повръщане), както и кожни алергични реакции.

Нежеланите реакции, свързани с количеството на прилаганата доза, обикновено отзвучават спонтанно след няколко дни или след временно понижаване на дозата. Нежеланите реакции от страна на ЦНС може да се развият при относително предозиране на продукта. В тези случаи се препоръчва проследяване нивата на карбамазепин в кръвта.

Съществуват съобщения за поява на костни заболявания, включително остеопения и остеопороза (изтъняване на костите) и фрактури (счупвания) по време на лечение с карбамазепин.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако приемате продължително лекарства против епилепсия, ако имате остеопороза или приемате стероиди.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни.

Спрете приема на Карбамазепин Актавис таблетки и незабавно уведомете Вашия лекар, ако получите:

- сериозни кожни реакции (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза) с обрив, зачервяване на кожата, мехури по устните, очите или устата, или излющване на кожата, съпроводени с треска, главоболие, кашлица, болки по тялото. Тези реакции се наблюдават по-често при пациенти от китайски или тайландски произход;
- бронхоспазм с хрипове и кашлица, затруднено дишане, чувство за слабост и замаяност, обрив, сърбеж или оток на лицето и гърлото (това може да са признаци на тежка алергична реакция);
- треска, гадене, повръщане, обърканост, главоболие, скованост на врата, силна чувствителност към светлина, контракции на мускулите (признаци на асептичен менингит);
- комбинация от висока температура, мускулна скованост, учестено дишане, изпотяване, замъглено съзнание и внезапна промяна в кръвното налягане и сърдечната честота, припадане (невролептичен малигнен синдром);
- втрисане, зачервяване на гърлото, обрив, афти в устата, подути жлези или податливост към инфекции (симптоми, свързани с намален или силно намален брой бели кръвни клетки (левкопения, агранулоцитоза));



- силно намаляване на броя на кръвните клетки, което може да доведе до слабост, поява на синини или увеличена вероятност от възникване на инфекция (панцитопения);
- уморяемост, обърканост, потрепване на мускулите, припадъци (ниско ниво на натрий в кръвта);
- халюцинации и възбуда (реактивна психоза);
- необясними синини или кръвене (тромбоцитопения);
- пожълтяване на кожата или бялото на очите с потъмняване на урината (възпаление на черния дроб);
- намалено количество урина поради бъбречно заболяване с поява на белтък в урината, понякога и кръв в урината, повишена урея в кръвта, оток на краката (бъбречна недостатъчност);
- пристъпи на невропатия, гърчове, халюцинации, депресия, безпокойство, повръщане и болки в корема, понякога съпроводени с болка в мускулите на крайниците или гърба, мравучкане, мускулната слабост и нарушени рефлексии (чернодробна порфирия), запек или диария или пък повишена кожна чувствителност към слънчева светлина с възпаляване на кожата - фотодерматит, мехури след зарастването на които остава промяна в цвета на кожата или некроза по кожата или венците, обриви, сърбеж и увеличено окосмяване на определени участъци (кожна форма на порфирия);
- болки в ставите и мускулите, обрив и зачервяване под формата на пеперуда върху лицето и проблеми с дишането (те могат да бъдат признаци на рядко срещана реакция, известна като лупус еритематозус);
- вид алергична реакция, която може да се прояви с треска, обриви, васкулит (възпаление на кръвоносните съдове, често съпроводено с кожни обриви), увеличение на лимфните възли, болка в ставите, левкопения, еозинофилия, увеличение на черния дроб и далака, отклонения от нормалните стойности на чернодробните функционални изследвания, в различни комбинации. Други органи също могат да бъдат засегнати (напр. черен дроб, бели дробове, бъбреци, панкреас, миокард, дебело черво) (това може да са признаци на засягане на множество органи, вследствие на свръхчувствителност);
- силна болка в горната част на корема, която преминава към гърба (възпаление на задстомашната жлеза);
- внезапна болка в крака със зачервяване и оток по хода на вената (тромбофлебит);
- повърхностно, учестено и мъчително дишане, кашлица – понякога с кървави храчки, ускорен сърдечен ритъм, задушаване, посиняване на лицето и крайниците (белодробна тромбоемболия).

По-надолу нежеланите лекарствени реакции са подредени по честота:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

- левкопения (намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции);
- замаяност;
- нарушение на равновесието;
- сънливост;
- умора;
- гадене;
- повръщане;
- повишение на някои чернодробни лабораторни показатели (гама-глутамил трансферазата), обикновено без клинично значение;
- алергичен дерматит;
- уртикария (копривна треска).



Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти)

- намаляване броя на тромбоцитите, което повишава риска от кървене или образуване на синини,
- еозинофилия (повишаване на броя на еозинофилите - определен вид бели кръвни клетки в кръвта;
- оток, задържане на течности, повишение на телото с ниско ниво на натрий в кръвта, което може да доведе до водна интоксикация, която протича с уморяемост, главоболие, повръщане, обърканост, потреперване на мускулите, неврологични отклонения;
- главоболие;
- двойно виждане;
- замъглено зрение;
- сухота в устата;
- повишение на серумната алкална фосфатаза.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти)

- абнормни неволеви движения (тремор);
- нестабилно кръвно налягане, отслабване, безсъние, задух, болки в областта на сърцето и гърдите, раздразнителност, потене (дистония);
- нистагъм (бързи, спонтанни, неволеви очни движения);
- диария;
- запек;
- повишение на трансаминазите (чернодробните ензими);
- ексфолиативен дерматит, еритродерма (вид тежки кожни увреждания със значимо нарушение на целостта на кожата).

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти)

- увеличаване на белите кръвни клетки (левкоцитоза);
- увеличение на лимфните възли;
- дефицит на фолиева киселина;
- мултиорганна свръхчувствителност (алергия) от забавен тип;
- халюцинации (зрителни и слухови);
- депресия;
- анорексия (психично заболяване с липса на апетит и отказ от храна);
- агресивно поведение;
- тревожност;
- обърканост;
- неволеви движения в областта на устата и лицето;
- гримасничене, отпускане на клепача;
- нарушения в речта (напр. неясен говор);
- неволеви, принудителни, бързи и резки движения на тялото;
- парестезии (изтръпване и мравучкане по кожата на ръцете и краката);
- нарушение на нервите, което може да доведе до слабост, изтръпване и мравучкане;
- нарушения в сърдечната проводимост;
- повишено или понижено кръвно налягане;
- болка в областта на корема;
- хепатит, жълтеница;
- системен лупус еритематодес (вълчанка);
- сърбеж.



Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 пациенти)

- силно намаляване броя на белите кръвни клетки, което увеличава вероятността от възникване на инфекции (агранулоцитоза);
- значимо намаляване броя на всички кръвни клетки, което води до слабост, поява на синини или увеличена вероятност от възникване на инфекции (апластична анемия);
- анемия (намаление броя на червените кръвни клетки, което води до бледност, слабост и задух);
- мегалобластна анемия (анемия с дефицит на витамин В12 и фолиева киселина);
- остра интермитентна порфирия, порфирия кутанеа тарда (заболявания, свързани с дефект в образуването на хемоглобина);
- панцитопения;
- нарушено образуване на червени кръвни клетки с повишен брой ретикулоцити (вид млади червени кръвни клетки), което води до тежка анемия;
- асептичен менингит - възпаление на мозъчните обвивки;
- анафилактична реакция (тежка алергична реакция, която причинява затруднения в дишането или замайване);
- ангионевротичен оток (тежка алергична реакция, която причинява подуване на лицето или гърлото);
- увеличение на пролактина (хормон, който стимулира продукцията на кърма) със или без клинични прояви като галакторея (отделяне на секрет, подобен на мляко от млечните жлези), гинекомастия (увеличение на млечните жлези при мъжа);
- абнормни функционални изследвания на щитовидната жлеза: понижено ниво на L-тироксина (свободен тироксин, тироксин, три-йодтиронин – хормони на щитовидната жлеза) и повишено ниво на ТСХ (стимулиращия щитовидната жлеза хормон, отделящ се от хипофизата), обикновено без клинични прояви;
- нарушения на костната обмяна, водещо до остеомалация/остеопороза (размекване на костите, намалена костна плътност);
- повишено ниво на холестерола и триглицеридите;
- реактивна психоза;
- вкусови нарушения;
- невролептичен малигнен синдром;
- помътняване на лещата;
- конюнктивит;
- покачване на вътреочното налягане;
- слухови нарушения, като шум в ушите, повишена или понижена острота на слуха, промяна в усещането за сила на звука;
- бавен или неритмичен сърдечен пулс;
- нарушения в проводимостта между предсърдията и камерите със загуба на съзнанието;
- циркулаторен колапс (загуба на съзнание поради рязко спадане на кръвното налягане);
- застойна сърдечна недостатъчност (сърдечно заболяване, което може да доведе до лесна уморяемост, задух, подуване на глезените);
- утежняване на исхемична болест на сърцето;
- тромбофлебит;
- тромбоемболия;
- белодробна свръхчувствителност, характеризираща се с треска, затруднено дишане, пневмонит (заболяване на белите дробове, което причинява задух, кашлица и повишаване на температурата) или пневмония.
- възпаление на езика и на лигавицата в устната кухина;
- възпаление на задстомашната жлеза (панкреатит);
- грануломатозен хепатит (вид хепатит);



- чернодробна недостатъчност;
- тежки кожни заболявания, свързани с образуване на мехури по кожата, по цялото тяло, вкл. в областта на лицето, очите, половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза);
- реакция на фоточувствителност (повишена кожна чувствителност към слънчева светлина);
- някои тежки кожни заболявания (еритема мултиформе, еритема нодозум);
- пурпура (възпаление на кръвоносните съдове с кожен обрив и проблеми със ставите);
- промени в кожната пигментация;
- акне;
- повишено потене;
- косопад. В редки случаи се съобщава за хирзутизъм (прекомерно окосмяване).
- болки в ставите и мускулите;
- мускулни спазми.
- интерстициален нефрит (увреждане на бъбречната тъкан);
- бъбречна недостатъчност;
- често уриниране;
- задръжка на урина;
- полова дисфункция/импотентност;
- нарушена сперматогенеза (с намален брой и/или понижена подвижност на сперматозоидите).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: 02 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Карбамазепин Актавис

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Карбамазепин Актавис

- Активното вещество е карбамазепин. Всяка таблетка съдържа 200 mg карбамазепин.
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, повидон, колоиден безводен силициев диоксид, глицерол, кросповидон, талк, магнезиев стеарат.



Как изглежда Карбамазепин Актавис и какво съдържа опаковката

Кръгли, плоски таблетки, с диаметър 10 mm и делителна черта от едната страна, с бял или почти бял цвят.

Таблетката може да бъде разделена на две равни дози.

По 10 таблетки в блистер от PVC/Al фолио

По 5 блистера в картонена кутия

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД

ул. Атанас Дуков № 29

1407 София,

България

Производител

Балканфарма-Дупница АД

ул. Самоковско шосе № 3

2600 Дупница,

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

